



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هنا حواش الهنداوي عيد

العنوان : مجاوره 11 عمالره 4
15 مايو القاهرة

المحافظة : المنوفيه الحى / المدينة : اخرى

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم البطاقة : 25907171701023 رقم التليفون : 01129397949

العمر (تاريخ الميلاد) : 17-07-1959 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)
المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج : الاورام [11129]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د.ا /د.ا /د.ا /د.ا /د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هنا حواش الهنداوي عبد National ID: 25907171701023	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



هنا
حواش الهنداوى عيد
مجاورة ١١ - حي أعمار ٤
خمس عشر مايو - القاهرة

١٩٥٩/٠٥/١٧ ٢٥٩.٧١٧١٧.١٠.٢٣

JJ7688632

عن

١١٩٩٣٩٧٩٤٩

١١١٨٦٤.٧٤٦

مكرر

٢٠٢٢/٠٥ ٢٥٩.٧١٧١٧.١٠.٢٣



رربة منزل
انثى مسلمة ارملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٥/٢٢

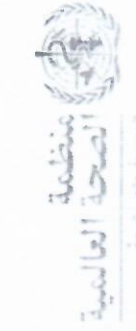


١٠٠ مليون
صحة

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



الصحة المصرية
مصر



الاسم: هنا حواسي الهنأدى القارىخ: ٢٠٢٧٨٢١٢
الرقم القومي: ٥٥٩٠٧١٧٧٧٠١٠
رقم التليفون: ٠١١٨٦٤٠٧٤٠٧٤٠٧٤٠

مستهدفة بالتوعية
مستهدفة بالتوعية والفحص الإكلينيكي

الوزن	الطول	مؤشر كتلة الجسم	قياس السكر الشفوي	قياس ضغط
85	161	168	170/20	

* فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً

أبريل 2024	مايو 2024	يونيو 2024	يوليو 2024	أغسطس 2024	سبتمبر 2024	أكتوبر 2024	نوفمبر 2024	ديسمبر 2024	يناير 2025	فبراير 2025	مارس 2025	أبريل 2025	مايو 2025	يونيو 2025	يوليو 2025	أغسطس 2025	سبتمبر 2025	أكتوبر 2025	نوفمبر 2025	ديسمبر 2025	يناير 2026	فبراير 2026	مارس 2026
------------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------

- حافظي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
- إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، استشيرى بالنظام طبيب تنظيم الأسرة.
- إطمئني ، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

موعد الفحص القادم:
المكان المحولة به للتقييم:
توقيع الطبيب:
موعد التقييم:

15335

www.100millionseha.eg

Name	Hana hwash elbadray
Date	Aug. 13, 2026
Time	2:09 PM

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:

Left breast:

- Edematous breast changes manifested by asymmetrical increased overall size, parenchymal coarsening and thickened skin.
- An ill-defined speculated hyperdense lesion is seen retroareolar at the left breast corresponding by US to an ill-defined speculated shaped heterogeneous hypoechoic lesion surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing, the lesion shows subcutaneous infiltration and nipple retraction. It measures about 5X 3.5cm.
- Few enlarged right axillary LNs showing effaced fatty hilum. The largest measures about 9mm in its SAD

Right breast:

- ACR C: mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- No speculated lesions or pathological micro calcification clusters.
- Normal central ducts system.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes of the left breast.
- Left nonspecific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS V) for further true cut biopsy & histopathological assessment.

Best regards,

Dr. Alaa.S.Khidr, Msc



رسوم الاستعلام 20 جنية

جاءه الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2026-8-17

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قاتون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قاتون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " و قاتون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

المسيد (ة) هنا حواش الهنداوى عيد بطاقة رقم 25907171701023
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى معاش بدون خصم حصه التأمين الصحي
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل

تاريخ الطباعة : 2026-8-17

الموظف المختص

محمود عبدالله



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد...

مسلسل 2052468



الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيه أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى



Patient Name	ها حواش الهذواى	Case No.	358933
Sex/Age	Female 67 Y	Patient No.	26054
Registered Date	18/8/2026 02:09:44 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:05:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:45:08 PM	Pathology No.	2630/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 18/08/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.7 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

* Histological type: Fragmented provisional tissue cores with intermediate and high-grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).
* No invasive component in submitted cores (Cannot be excluded due to the fragmentation of cores).

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Positive.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Intermediate and high-grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).

IPT:

- ER: Positive.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



مستشفى ١٥ مايو
15 May Hospital



Name	Hana hwash elbadray
Date	Aug. 13, 2026
Time	2:08 PM

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:

Left breast:

- Edematous breast changes manifested by asymmetrical increased overall size, parenchymal coarsening and thickened skin.
- An ill-defined speculated hyperdense lesion is seen retroareolar at the left breast corresponding by US to an ill-defined speculated shaped heterogeneous hypoechoic lesion surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing, the lesion shows subcutaneous infiltration and nipple retraction. It measures about 5X 3.5cm.
- Few enlarged right axillary LNs showing effaced fatty hilum. The largest measures about 9mm in its

SAD

Right breast:

- ACR C: mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- No speculated lesions or pathological micro calcification clusters.
- Normal central ducts system.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes of the left breast.
- Left nonspecific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS V) for further true cut biopsy & histopathological assessment.

Best regards,

Dr. Alaa.S.Khidr, Msc



١١٧٦٤٧٤٦١

الجمهورية العربية السورية
محافظة حلب

مجلس المحافظة
محافظة حلب
مجلس حلب - القامشلي

٢٥٩٠٧١٧١٧٠١٠٢٣

١١٧٦٤٧٤٦١

١١٧٦٤٧٤٦١

١١٧٦٤٧٤٦١

١١٧٦٤٧٤٦١

١١٧٦٤٧٤٦١

١١٧٦٤٧٤٦١

١١٧٦٤٧٤٦١



١١٧٦٤٧٤٦١



١١٧٦٤٧٤٦١



Patient Name	ها حواش الهذوى	Case No.	358933
Sex/Age	Female 67 Y	Patient No.	26054
Registered Date	18/8/2026 02:09:44 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:05:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:45:08 PM	Pathology No.	2630/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 18/08/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.7 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

* Histological type: Fragmented provisional tissue cores with intermediate and high-grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).
* No invasive component in submitted cores (Cannot be excluded due to the fragmentation of cores).

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Positive.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Intermediate and high-grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).

IPT:

- ER: Positive.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



مستشفى ١٥ مايو
15 May Hospital



Name	Hana hwash elbadray
Date	Aug. 13, 2026
Time	2:08 PM

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:

Left breast:

- Edematous breast changes manifested by asymmetrical increased overall size, parenchymal coarsening and thickened skin.
- An ill-defined speculated hyperdense lesion is seen retroareolar at the left breast corresponding by US to an ill-defined speculated shaped heterogeneous hypoechoic lesion surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing, the lesion shows subcutaneous infiltration and nipple retraction. It measures about 5X 3.5cm.

Few enlarged right axillary LNs showing effaced fatty hilum. The largest measures about 9mm in its SAD

Right breast:

- ACR C: mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- No speculated lesions or pathological micro calcification clusters.
- Normal central ducts system.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes of the left breast.
- Left nonspecific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS V) for further true cut biopsy & histopathological assessment.

Best regards,

Dr. Alaa.S.Khidr,Msc



الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

3

مراض البنداری عبد

مجاورہ ۱۱- حصہ ۱- عصارہ ۱۱
حصہ ۱۱ - عصارہ ۱۱ - عصارہ ۱۱

Y 04 . V 1 V 1 V . 1 . Y 1

317688632

McRae

4

111732111.

13

W. C. C. C.
C. C. C. C.

2541

7.171.2

759:4148-1-1-TT

ریبہ منبر

五

in

5.

السلطنة سارية حتى ٢٠٢٢.٠٩.٢٠



~~2. 10~~

Patient Name	ها حواش الهذواى	Case No.	358933
Sex/Age	Female 67 Y	Patient No.	26054
Registered Date	18/8/2026 02:09:44 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:05:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:45:08 PM	Pathology No.	2630/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 18/08/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.7 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

* Histological type: Fragmented provisional tissue cores with intermediate and high-grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).

* No invasive component in submitted cores (Cannot be excluded due to the fragmentation of cores).

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Positive.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Intermediate and high-grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).

IPT:

- ER: Positive.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



مستشفى ١٥ مايو
15 May Hospital



Name	Hana hwash elbadray
Date	Aug. 13, 2026
Time	2:08 PM

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:

Left breast:

- Edematous breast changes manifested by asymmetrical increased overall size, parenchymal coarsening and thickened skin.
- An ill-defined speculated hyperdense lesion is seen retroareolar at the left breast corresponding by US to an ill-defined speculated shaped heterogeneous hypoechoic lesion surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing, the lesion shows subcutaneous infiltration and nipple retraction. It measures about 5X 3.5cm.

Few enlarged right axillary LNs showing effaced fatty hilum. The largest measures about 9mm in its SAD

Right breast:

- ACR C: mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- No speculated lesions or pathological micro calcification clusters.
- Normal central ducts system.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes of the left breast.
- Left nonspecific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS V) for further true cut biopsy & histopathological assessment.

Best regards,

Dr. Alaa.S.Khidr,Msc

[illegible][illegible]

၂၀၁၂ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖုန်းတီးမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ
 - မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ

၁၂၄၂၆၀၀ ကုမ္ပဏီ (ပတ်ဝန်းကျင်)

- ስለፍጥነት ማረጋገጫ ማስፈጸም

၁၂၄၆၀၀ ကျပ် (၂၅၂၂၀၀)

[illegible][illegible]

יְהוָה יִשְׁמַר אֶת יְהוּדָה וְיִשְׁכָּן יִשְׂרָאֵל וְיִשְׁכָּן יִשְׂרָאֵל

[illegible]

၈။ အထွေထွေအားဖြင့် နယ်လုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေအထားနှင့်
 - နယ်လုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေအထားနှင့် နယ်လုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေအထား

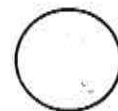
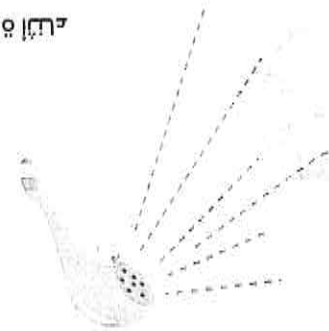
၁၂၄၂၆၀၀၀၀ (၁၂၄၂၆၀၀၀)

[illegible]

مجلس الشورى

[illegible][illegible]

ബന്ധപ്പെടാനി



ጠላቅ ስጦታ ስጦታ ጠላቅ ስጦታ ጠላቅ

- နေပြည်တော်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်

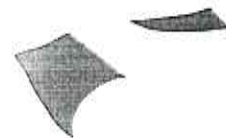
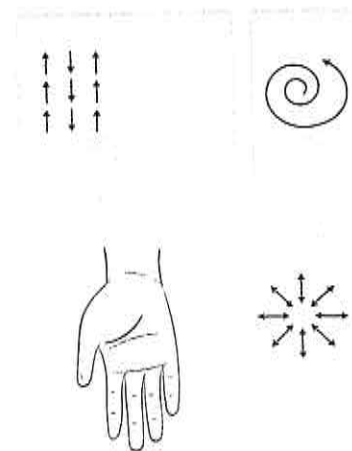
6/11/2017
- 10/11/2017

1. ሥነ ምግባርና ሥነ ጥበቃ ማረጋገጫ
 2. ሥነ ጥበቃ ማረጋገጫ
 3. ሥነ ጥበቃ ማረጋገጫ
 - ሥነ ጥበቃ ማረጋገጫ

1. ስለ ስልጣን ማግኘት
 2. ስለ ስልጣን ማግኘት
 3. ስለ ስልጣን ማግኘት
 4. ስለ ስልጣን ማግኘት

[illegible][illegible]

༡༥༥༦ ལོ། (༡༩༩༩)



15. 11. 2023
 (15. 11. 2023)